



Bipolar Bozukluk

Bipolar bozukluk, mani veya hipomani ve depresif dönemlerle seyreden, kişinin ruh hali, enerji düzeyi, aktivitesi ve düşüncelerini etkileyen kronik bir ruhsal bozukluktur. Dünya genelinde yaklaşık 37–40 milyon kişiyi etkilediği bildirilmektedir. Hastalık genellikle geç ergenlik veya erken yetişkinlik döneminde başlar ve yaşam boyu tekrarlayabilen bir seyir gösterebilir. Bipolar bozukluk yalnızca duygu durumunda değişikliklere değil; iş, eğitim, aile ilişkileri ve günlük işlevsellikte önemli bozulmalara da yol açabilir. Ayrıca intihar, anksiyete ve madde kullanım bozuklukları açısından risk artışıyla ilişkilidir. [1–3]

Bipolar bozuklukta mani döneminde aşırı neşe veya iritabilite, belirgin enerji ve aktivite artışı, uyku ihtiyacında azalma, hızlı konuşma ve düşüncelerin hızlanması, dikkat dağınıklığı, kendini aşırı önemli veya güçlü hissetme ve riskli davranışlarda artış görülebilir. Ağır durumlarda gerçeklikle bağın bozulduğu psikotik belirtiler ortaya çıkabilir. Depresif dönemde ise çökkün ruh hali, ilgi ve zevk kaybı, enerji azalması, konsantrasyon güçlüğü, uyku ve iştah değişiklikleri, suçluluk veya değersizlik duyguları, umutsuzluk ve ölüm ya da intihar düşünceleri görülebilir. Depresif belirtilerin en az iki hafta boyunca, günün büyük bölümünde ve neredeyse her gün sürmesi, sıradan ruh hali dalgalanmalarından ayrılmasında önemlidir. Hipomani, maniyeye benzer ancak daha hafif seyreden ve genellikle işlevselliği aynı ölçüde bozmayan bir dönemdir. [1–3]

Bipolar bozukluğun Bipolar I ve Bipolar II olmak üzere iki temel tipi vardır. Bipolar I bozukluğunda belirgin manik dönemler görülür ve depresif dönemler de eşlik edebilir. Bipolar II bozukluğu ise hipomanik ve depresif dönemlerin örüntüsüyle karakterizedir; geçmişte manik dönem bulunmaz. NIMH ayrıca daha hafif ve kısa süreli hipomanik ve depresif belirtilerin tekrarladığı siklotimik bozukluğu ayrı bir bipolar bozukluk türü olarak tanımlar. [3]

Hastalığın kesin nedeni tam olarak bilinmemektedir. Araştırmalar, genetik yatkınlığın

yanı sıra biyolojik, psikolojik ve sosyal etkenlerin birlikte rol oynadığını göstermektedir. Tek bir gen hastalığa neden olmaz; çok sayıda genin etkisi ve stresli veya travmatik yaşam olayları arasındaki etkileşim önem taşıyabilir. Yas, ilişki kaybı ve diğer stres kaynakları belirtileri tetikleyebilir veya kötüleştirebilir. [1–3]

Bipolar bozuklukta tedavi mümkündür ve iyileşme hedeflenebilir. Tedavinin temelini duygudurum dengeleyiciler ve uygun antipsikotik ilaçlar oluştururken, psikoterapi ve psikososyal müdahaleler tedavinin önemli tamamlayıcılarıdır. Lityum gibi bazı duygudurum dengeleyiciler atakların önlenmesine yardımcı olabilir ve intihar riskini azaltabilir. Bilişsel davranışçı terapi, psikoeğitim ve kişilerarası/sosyal ritim terapisi gibi psikolojik yaklaşımlar belirtilerin ve nükslerin azaltılmasına katkı sağlayabilir. Düzenli uyku, fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme, stresin azaltılması ve ruh halinin izlenmesi de tedaviyi destekler. [1–3]

Sonuç olarak bipolar bozukluk, yalnızca ruh hali değişimlerinden ibaret olmayan; kişinin işlevselliğini, yaşam kalitesini ve sosyal ilişkilerini etkileyebilen ciddi ancak uygun ve sürekli tedaviyle yönetilebilen bir hastalıktır. Erken ve doğru tanı, bireye uygun tedavi, psikososyal destek ve tedaviye süreklilik, hastalığın kontrolünde temel unsurlardır. [1–3]

Kaynaklar:

- [1] Singh B, Swartz HA, Cuellar-Barboza AB, Schaffer A, Kato T, Dols A, Sperry SH, Vassilev AB, Burdick KE, Frye MA. Bipolar disorder. *Lancet*. 2025 Aug 30;406(10506):963-978. doi: 10.1016/S0140-6736(25)01140-7. Epub 2025 Jul 22. PMID: 40712624; PMCID: PMC12340982.
- [2] World Health Organization. (2025, September 8). *Bipolar disorder*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/bipolar-disorder>
- [3] National Institute of Mental Health. (2025). *Bipolar disorder*. U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health. <https://www.nimh.nih.gov/health/publications/bipolar-disorder>